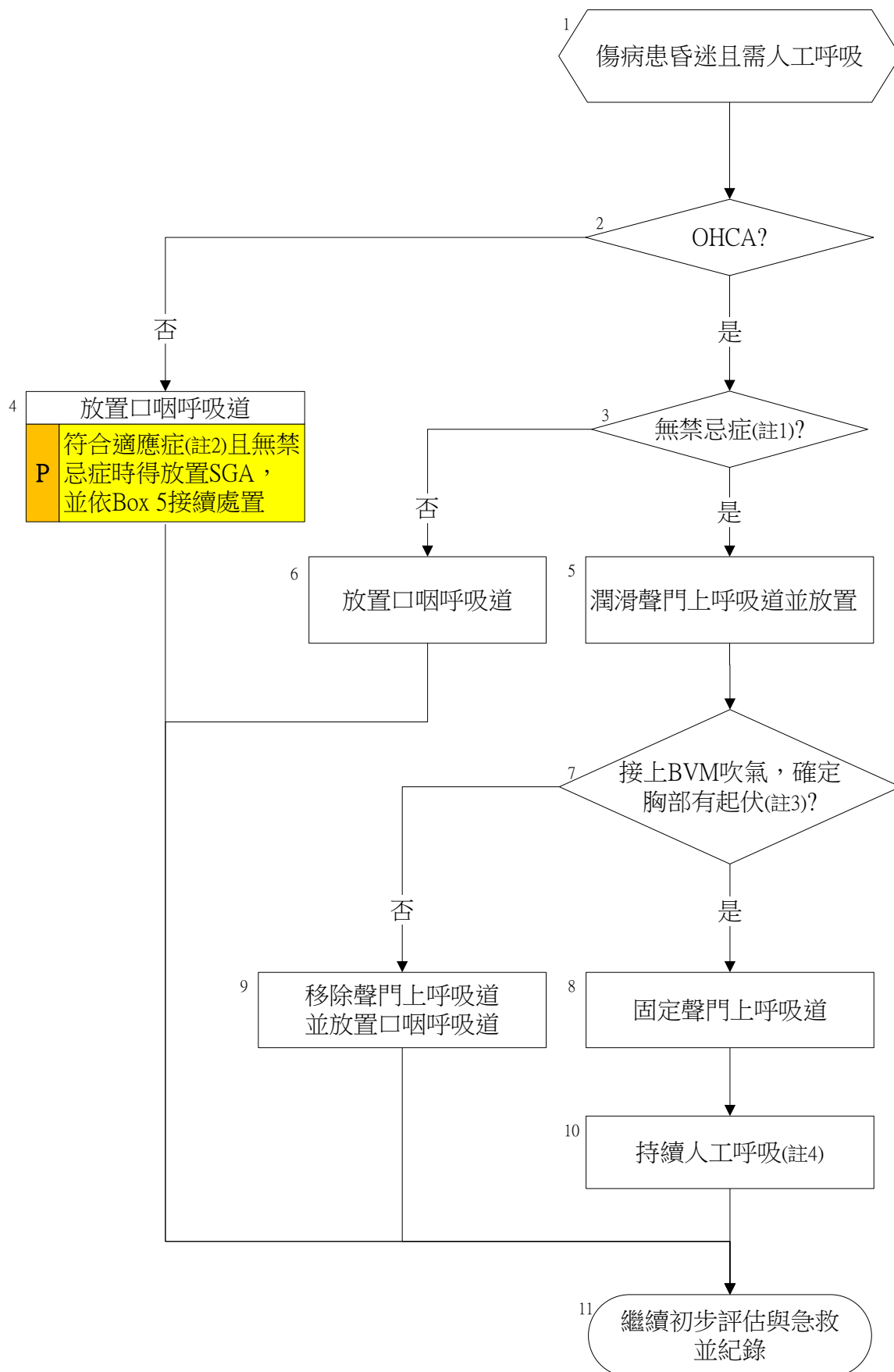


A2 聲門上呼吸道裝置 (Supraglottic Airway Device)

程 序



要 旨

- 一、現場操作聲門上呼吸道裝置（Supraglottic Airway Device）置入時，應特別注意三件事：選擇正確尺寸及良好固定；勿影響 CPR 品質；搬運過程勿造成裝置移位或脫落。
- 二、若有設備許可，應使用Capnography監測。
- 三、若進階呼吸道嘗試置入失敗或明顯移位時，應儘快改用輔助呼吸道及BVM。

註 解

註1>

- 一、**禁忌症**：食道、咽喉病變；傷病患無法張開口（最少上下齒幅空間為2公分寬）；明顯因異物哽塞造成之OHCA；氣切病人之OHCA。
- 二、放置前口中有異物(如不穩固之假牙、鼻胃管…等)時，應先移除。

註2>

適應症

P 適用於昏迷的傷病患，且需要甦醒球人工呼吸，並符合下列任一情形時：

- 一、BVM人工呼吸操作不易或困難時。
- 二、BVM人工呼吸無法改善缺氧狀況時。
- 三、頸椎傷患無法持續用下顎推舉法維持暢通的呼吸道時。
- 四、需要較長的時間（≥10分鐘）轉送至急救責任醫院時。

註3>

接上BVM通氣無可見的胸部升起時，應考慮下列情形：

- 一、漏氣：如BVM通氣阻力很小且有漏氣聲音，應確認SGA與BVM接合處是否漏氣；如無上述情形，評估SGA號數是否恰當(如:是否太小)；如確認SGA號數適當，應重新確認SGA位置是否正確;如為LMA，檢查氣囊是否已打飽或有破裂情形。
- 二、異物(或痰)阻塞：當BVM通氣阻力變大時，考慮進行抽吸。
- 三、當上述評估皆無異常發現時，可考慮更換另一個BVM進行通氣。

註4>

不論有無脈搏每分鐘給予10次(約6秒1次)之人工呼吸；但若為1人CPR時，與胸部按壓依30:2之比例進行。